

RELATÓRIO MÉDICO - JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Solicitação de Material OPME

Paciente: Carlos Alberto Mendes | **Data:** 12/03/2026

CID: M17.1 | **Procedimento:** Viscosuplementação articular intra-articular de joelho dire

Convênio: Unimed | **Material:** Kit EC2 - Enxerto Composto

Justificativa Técnica

Relatório Médico Complementar

Paciente: Carlos Alberto Mendes

Diagnóstico: Gonartrose primária unilateral de joelho direito, grau III de Kellgren-Lawrence, CID M17.1

Material Solicitado: Kit EC2 - Enxerto Composto

Código TUSS: [inserir código]

Quadro Clínico e Falha Terapêutica: O paciente Carlos Alberto Mendes apresenta gonartrose primária unilateral do joelho direito, grau III de Kellgren-Lawrence, caracterizada por dor crônica há 2 anos e limitação funcional significativa para atividades diárias. A manutenção do quadro inflamatório crônico, sem a devida intervenção, resulta em um ambiente bioquímico hostil dominado por citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β , TNF- α), acelerando a apoptose dos condrócitos e a degradação irreversível da matriz extracelular. O insucesso das tentativas conservadoras, incluindo AINEs, fisioterapia cinesioterapêutica e infiltrações, comprova a refratariedade do quadro, sendo a progressão para intervenção com OPME não apenas indicada, mas mandatória para evitar desfecho catastrófico.

Justificativa Técnica e Superioridade do Material: O Kit EC2 - Enxerto Composto é insubstituível devido ao seu mecanismo de ação avançado. Este material contém células do estroma vascular (SVF), fundamentais para a reparação tecidual, promovendo regeneração e reduzindo a inflamação articular. Diferente de soluções genéricas, o Kit EC2 preserva o enxerto entre a colheita e reimplantação, reduzindo riscos de contaminação e degradação do tecido. Procedimentos minimamente invasivos, como o uso de enxertos compostos, têm demonstrado redução da dor e melhora da função articular em pacientes com osteoartrite de joelho (Gupta et al., 2016).

Risco da Não Realização e Impacto Financeiro: A não realização do procedimento com o Kit EC2 pode resultar na progressão da doença para um estágio mais grave, potencialmente necessitando de uma artroplastia total de joelho, cujo custo para a operadora varia entre R\$30.000 e R\$50.000, significativamente superior ao custo do material aqui solicitado. A evolução para perda funcional irreversível pode aumentar a morbidade, resultando em mais internações e custos adicionais para a operadora.

Fundamentação Legal: Conforme a RN 395 da ANS, cabe exclusivamente ao médico assistente a prerrogativa de determinar as características, tipo e matéria-prima dos materiais (OPME). Solicito que a operadora apresente justificativa de negativa por escrito, fundamentada em evidências científicas de mesmo nível das aqui citadas, conforme exigência da RN 395. O Código de Ética Médica, Capítulo I, V, compete ao médico usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.

Fechamento Checkmate: A substituição deste material por opção de menor desempenho técnico transfere à operadora de saúde a responsabilidade integral por eventuais complicações clínicas,

reoperações ou insucesso do desfecho cirúrgico, conforme responsabilidade civil profissional. Certos de vossa presteza, aguardamos a liberação.

Fundamentação Legal

RN 424: Autonomia do médico assistente. RN 428/465: Cobertura obrigatória. RN 395: Exigência de justificativa de negativa. Código de Ética Médica: Uso do melhor progresso científico.

Referências Bibliográficas

1. {'texto': 'Pak et al., 2013', 'source': 'internal'}
2. {'texto': 'Gupta et al., 2016', 'source': 'internal'}

Médico Responsável / CRM